

OSCE Checkliste Dermatologie

Einleitung in die Anamnese

- Händedesinfektion
- Begrüssen (Patient mit Namen ansprechen)
- Sich vorstellen (Namen, Funktion)
- Gesprächsrahmen deklarieren (Zeitbude, Ziel)
- Sich vergewissern, ob man vom Patienten verstanden wird (Sprache, Dialekt, Hörschädigung)
- Adäquate Situation schaffen (Fenster schliessen, Augenhöhe, Distanz)
- Sich vergewissern, ob Patient bequem sitzt

Anamnese:

Jetziges Leiden der Hautveränderung

- Beginn: Flush (plötzlich), langsam progredient, schubweise
- Dauer: akut, chronisch
- Verlauf: einmalig, dauernd, rezidivierend, intermittierend
- Objektive Symptome: Aussehen, Farbe, Form, Grösse, Lokalisation und Ausbreitung: immer Nachfragen anogenital und oral!
- Subjektive Symptome:
 - Juckreiz inkl. Kratzverhalten
 - Brennen
 - Schmerz
 - Vermehrtes Schwitzen
- B-Symptome: FIEBER, grippale Symptome, Gewichtsverlust, Nachtschweiss, Müdigkeit, Leistungsschwäche
- Andere Begleiterkrankungen/Begleitsymptome → Dermatosen können Systembeteiligung bewirken!
- Veränderungen Nagel, Haare, Schleimhaut aufgefallen?
- Verstärkende Faktoren / Zeitlicher Zusammenhang mit:
 - Arzneimittel: Dauer, Dosis, Bedarfmedikation, „over the counter-Mittel“
 - Stress
 - Gravidität, Menstruation
 - Physikalische Faktoren: UV-Licht, Temperatur, mechanische Belastung, Hitze
 - Beruf: Staub, Allergene, Irritanzen, Feuchtigkeit..
 - Freizeit/ Hobby: Werkstoffe, Pflanzen, Chemikalien, Tiere
 - Tierkontakte! → v.a. Epizoonosen und Allergien
 - Reisen
 - Nahrungsmittel
 - Kosmetika
- Verbessernde Faktoren
- Bisherige Therapie: lokal, systemisch, Effekt der Therapie (Erfolg/Misserfolg)
- Psychogene Belastungsfaktoren
- Lebensqualitätseinschränkungen durch Hautveränderung, Schlafstörungen durch HV

Umgebungsanamnese:

- Reiseanamnese
- Infektionskrankheiten (Skabies, Varizellen..)
- Ggf. Sexualpartner bei Vd. a. STD

Persönliche Anamnese:

- Bekannte Allergien und jeweilige Reaktion
- Bekannte Hautkrankheiten
- Atopische Erkrankungen
 - Atopische Dermatitis
 - Allergische Rhinitis
 - Asthma bronchiale
 - Nahrungsmittelunverträglichkeit
- Internistische Erkrankungen
 - Diabetes
 - Schilddrüsenerkrankungen
 - Immundefizienz
- Autoimmunkrankheiten
- Maligne Erkrankungen
- Immundefizienz (Immunsuppressiva, HIV..)
- Infektionskrankheiten
 - HIV, Hepatitis, STD
 - Bei Vd. auf Infektionskrankheit immer nach Schwangerschaft fragen
- Impfanamnese, durchgemachte Kinderkrankheiten
- Operationen
- Implantate

Medikamentenanamnese

Familienanamnese/Genodermatosen

- Ähnliches in Familie bekannt?
- Disposition für atopische Erkrankungen und Psoriasis
- Genodermatosen (vererbare Hautkrankheiten)
-

Sozialanamnese:

- Beruf
- Hobbies

Klinische Untersuchung

Inspektion und Palpation der HV inkl. Photodokumentation

- AZ: normal, reduziert, stark reduziert
- GESAMTER KÖRPER genau inspizieren!!! Patient muss vollständig entkleidet sein
 - Haut von Kopf bis Fuss inkl. interdigital und retroaurikulär, Hautfalten
 - Haare und Kopfhaut
 - Nägel
 - Schleimhäute (enoral) → jedem Patienten in Mund schauen!

LK-Status: bei Vd. a. Infektiöse oder Maligne Prozesse

Evt. Gefäss-Status

Beschreibung des Befundes

Primäre/ sekundäre Effloreszenzen beschreiben:

Primäre Effloreszenzen:

- Makula (Fleck): Veränderung Hautfarbe im Hautniveau

- Papel (Knötchen) (<1cm): fest erhabene Läsion
- Nodus (Knoten) (>1cm): fest erhabene Läsion, reicht tiefer (Dermis, Subkutis)
- Tumor
- Urtica (Quaddel): umschriebene Schwellung leicht rötlich mit Randsaum (Halo)
- Vesicula (Bläschen) (<5mm): mit freier Flüssigkeit gefüllte Hautveränderung (Lymphe, Serum, Blut)
- Bulla (Blase) (>5mm): mit freier Flüssigkeit gefüllte HV (Lymphe, Serum, Blut)
- Pustel: umschriebene HV mit purulentem Exsudat gefüllt mit oder ohne Beziehung zu Haarfollikel / Schweissdrüsen
- Zyste: abgekapselter subepidermaler Hohlraum durch Epithel ausgekleidet (Pseudozyste: keine Epithelauskleidung)

Sekundäre Effloreszenzen:

- Squama (Schuppe): Verbände verhornter Epithelzellen durch verminderte Abstossung oder vermehrte Proliferation
 - o Psoriasiform: grobe Schuppung
 - o Pityriasiform: feine Schuppung
- Crusta (Kruste): Eintrocknung seröser, blutiger, purulenter Exsudate
- Substanzdefekte:
 - o Erosion: epidermaler Substanzdefekt → Abheilung ohne Narbe
 - o Exkoration: Freilegung der Dermis mit leichten Punktblutungen durch Verletzung der Kapillaren in den Papillenspitzen (bis Stratum papillare reichend) → Feinste Narben
 - o Ulcus (Geschwür): bis in Tiefe (Subkutis, Faszien, Knochen) reichender Substanzdefekt → Narbe
- Atrophie: Gewebeverlust durch Abnahme einzelner Strukturen oder der gesamten Hautschichten
 - o Epidermis: Verdünnung, zigarettenpapierartige Fältelung
 - o Dermis: Eindellung, Hervortreten der Gefäßzeichnung, dünne aufgehobene Hautfalten
 - o Subkutis: muldenartige Eindellung
- Cicatrix (Narbe): Defektheilung durch tieferen Substanzdefekt: atroph, hypertroph
- Rhagade (Fissur): lineare Spaltbildung der Haut bis in Dermis reichend
- Lichenifikation: Verdickung und Vergrößerung der Hautfelderung
- Hautzyste: durch Kapsel abgeschlossener Hohlraum mit Inhalt (durch Epithel ausgekleidet)

Weitere Begriffe:

- Plaque: Herdförmig zusammenfliessende (konfluierende) Papeln, über Hautniveau erhabener Fleck
- Erythem = Hautrötung bedingt durch Gefässdilatation, mit Spatel wegdrückbar
- Erythrodermie = generalisierte entzündliche Rötung die >90% der Hautoberfläche betrifft
- Purpura: Blutungen, mit Spatel nicht wegdrückbar
- Exanthem = Hautausschlag
- Enanthem = Ausschlag der Schleimhäute
- Ekzem(Dermatitis) = nicht-infektiöse Entzündungsreaktion der Haut
- Frassgang

Weitere Beschreibung der Effloreszenzen

- Anzahl
- Farbe
Benennung der Farbtöne, z. B. rot, livid, apfelgelee-farben
- Form

rund, ovalär, anulär (ringförmig), arciform (bogenförmig), polyzystisch (wolkig), kokardenförmig (Schiessscheibe), konfettiartig, girlandenartig(gyriert), dendritisch (sternenartig), verrukös (warzenartig)

- Grösse
Grössenangaben sollten in einem metrischen Mass erfolgen; bei vielen Einzelläsionen empfiehlt sich die Angabe der typischen Spannbreite (z. B. 2–6 mm)
- Begrenzung
scharf versus unscharf
- Lokalisation:
Prädilektionsstellen beschreiben: Sonnenexponierte Areale, Intertrigines, etc.
best. Areale offensichtlich ausgespart?
bei Einzelläsion Benennung der betroffenen Stelle
- Verteilung:
diskret
lokalisiert = eine Region;
limitiert = wenige (bis 5) Regionen;
generalisiert = viele Körperregionen;
universell = alle Körperregionen
Körperseiten: einseitig, einseitig betont, beidseitig gleichförmig verteilt
- Anordnung
diffus = alles gleichmässig betroffen;
disseminiert = regellose Streuung der Einzelläsionen;
gruppiert = Läsionen finden sich überwiegend in Gruppen mit nur wenigen Einzelläsionen konfluierend
linear, strichförmig
zosteriform (Dermatom)
herpetiform (gruppiert)
Ausrichtung entlang Hautspaltlinien (Blaschkolinien)
- Symmetrie:
zeigen Einzelläsionen Achsen- oder gar Punktsymmetrie? Asymmetrisch?
- Oberflächenbeschaffenheit:
z. B. kleinpapulös, zerklüftet,
epidermale Beteiligung (Schuppung, Verhornung)
- Konsistenz:
z. B. prall-elastisch bei Zysten, derb bei Dermatofibromen
- Dynamik
Zentrifugale Ausbreitung (in alle Richtungen), Serpiginöse Ausbreitung (nur in eine Richtung)
Alte vs. neue Läsionen ersichtlich?
- Palpation
Konsistenz, Verschiebbarkeit, Fluktuation
Temperatur
- Geruch
- Nagelveränderungen
Nagelform, Nagelfarbe, Nageldicke, Nageloberfläche, Nagelstruktur
- Haarveränderungen
Anzahl (Haarverlust, Hirsutismus), Haarverteilung, Haarstruktur (Qualität, Form)
- Schleimhautveränderungen
- Begleitsymptome:
Überwärmung, Juckreiz, Brennen, einschliessende Schmerzattacken, Seborrhö/Sebosthase..

Beschreibung von Melanozytären Läsionen

A: Asymmetrie

B: Begrenzung (unscharf)

C: Color (verschieden farbig, inhomogene Pigmentierung)

D: Durchmesser (ab >6mm verdächtig)

E: Evolution/Veränderungen im Verlaufe der Zeit

Weitere Kriterien Malignität:

- Pseudopodien
- Zentral hyperpigmentiert, peripher hypopigmentiert (typisch Malignes Melanom)

Weitere Untersuchungen

Diaskop

Farbcharakteristika von HV untersuchen → mittels durchsichtigen Spatel auf Haut drücken:

Intravaskuläres Blut wird durch Kompression verdrängt und die Haut blasst ab (z.B. Erythem), extravaskuläres Blut verschwindet nicht durch Kompression (Purpura: Petechien, Ekchymosen, Suffusionen).

Dermatoskop (Auflichtmikroskop/Handlupe)

2-10fache Vergrößerung → morphologische Details v.a. melanozytäre Veränderungen

Tzanck-Test

- Pemphigus vulgaris → akantholytische Zellen
- HSV1, HSV2, VZV → multinukleäre Riesenzellen

Bakterielle Untersuchung

→ Abstrich und Gram-Färbung

→ Kultur, Antibiotogramm

→ (PCR)

→ (Histologie)

Virale Untersuchung

→ Antigen/Erregernachweis: Abstrich und Giemsa-Färbung, Histologie, Elektronenmikroskopie, DIF, Kultur

→ Ak-Nachweis: Serologie

→ Genomnachweis: PCR

Pilzuntersuchung: DHS-System(Dermatophyten, Hefepilze, Schimmelpilze)

Haut: Von frischen Herden (aktiver Randsaum), Haare aus Herd, Pustelinhalt

Mittels scharfem Löffel oder Skalpell

Nagel: Übergang gesund/befallen, subunguales Keratin

→ Kalilaugepräparat (KOH): Schuppenmaterial, Nagelmaterial, Haare aus der Läsion auf Objektträger mit 15% Kalilauge inkubieren bis sich Hornmaterial auflöst → Dermatophysen, Hefepilze werden angefärbt

→ Grampräparat: Ausstrich von Läsionen wird nach Gram gefärbt → Hefepilze sind als grampositive Zellen sichtbar

→ Evt. spez. Fluoreszenzfarbstoffe

→ Histologie: PAS-Färbung des histologischen Schnittes mit Darstellung des Pilzmaterials

→ Pilzkultur (Spez. Nährboden) (Cave: Dermatophyten benötigen 3 Wochen, Hefe und Schimmelpilze Tage)

Hautbiopsie und histopathologische Untersuchung

Indikation:

-frische Hautläsionen: Wenn möglich frische Läsion (Primäreffloreszenz)

-Hauttumore

- normale Histologische Untersuchung
- Direkte Immunfluoreszenz: häufig entscheidende Diagnostische Merkmale in der DIF!! Durch Nachweis von Autoantikörpern, Komplement
Bsp: Pemphigoid, Epidermolysis bullosa, Lupus erythematoses, Dermatitis herpetiformis, Porphyrie, Purpura Schönlein-Henoch

Exzisionsbiopsie

- Messerbiopsie = normales Herausschneiden
= vollständiges Herausschneiden inkl. subkutanen Fettgewebe mit Skalpell. Defekt mittels Hautnaht verschliessen
Fixierung in Formalin
Indikation: v.a. wenn ausgedehntere Areale biopsiert werden sollen oder wenn subkutanen Fettgewebe dargestellt werden soll, Verdächtige Läsionen komplett Herausschneiden
- Sonderform: Shave-Exzision
= oberflächliche tangentielle oberflächliche Abtragung mittels Skalpell. Wunde heilt alleine
Fixierung in Formalin
Indikation: oberflächliche v.a. in Epidermis liegende Prozesse (NICHT bei Malignen Prozessen!)

Stanzbiopsie (Inzisionsbiopsie)

in Lokalanästhesie!

Stanzzylinder wird eingedreht und dann entfernt, das Stanzpräparat aus der Haut gelöst. Hautdefekt muss genäht werden

Fixierung in Formalin

Indikation: Dermatosen die sich in Epidermis und Dermis abspielen, bei Verdächtigen Läsionen aber kosmetisch ungünstiger Läsion zuerst mittels Stanzbiopsie histologisch sichern bevor vollständige Exzision notwendig

Allergologische Testmethoden

Immunsuppressiva / Kortikoide / Antihistaminpräparate müssen genügen vorher abgesetzt werden um Testung durchführen zu können!

Pricktest

Indikation: Vd. a. Typ-I-Sensibilisierung (Bsp atopische Dermatitis)

Durchführung: Allergen (Lösung) mit Hilfe Prick-Lanzette in Dermis der Beugeseite des Unterarms einbringen = Testreihe. Zusätzlich Positivkontrolle (Histamin) und Negativkontrolle (NaCl)

Testsubstanzen: Kommerzielle Produkte erhältlich wie Pollen, Tierepithelien, Milben, etc.. auch eigene Substanzen möglich

Beurteilung: nach 15-20 Minuten, Beurteilung relativ zur Positiv- und Negativkontrolle

Intrakutantest

Indikation: Vd. a. Typ-I-Sensibilisierung (sensitiver als Pricktest)

Durchführung: Allergen wird als Lösung mit Hilfe einer Tuberkulinspritze in die Dermis des Unterarms eingebracht

Testsubstanzen/Beurteilung wie Pricktest

Epikutantest

Indikation: Vd. a. Typ-IV-Sensibilisierung (Bsp allergisches Kontaktekzem)

Durchführung: Haut wird entfettet. Allergene werden in Testkammern eingebracht und für 48 h auf die Haut fixiert (meist Rücken).

Beurteilung: Patient darf nicht duschen! 1. Beurteilung nach 48 h ; 2. Beurteilung nach 72h: nur wenn sich crescendo-Reaktion von 1. auf 2. Ablesen zeigt ist Test positiv, d.h. allergisch, bei decrescendo-Reaktion spricht es für irritativ-toxisches Geschehen

In-Vitro Diagnostik

Gesamt-IgE im Serum:

Indikation: atopische Erkrankungen, andere Typ1 Allergien (Arzneimittel, Nahrungsmittel..)

Beurteilung: bei Werten >100kU/l atopische Disposition wahrscheinlich

Zudem erhöhte Werte bei:

- Parasitosen
- Hyper-IgE-Syndrom
- IgE-Gammopathie, IgE-Myelom
- Z.T. virale Erkrankungen

Spezifisches IgE im Serum

Indikation: Vd. a. Typ I Sensibilisierung, v.a. wenn Hauttests (Prick/Intrakutantest)

kontraindiziert sind (sehr starke Reaktionen, Allergen nicht verfügbar)

Testsysteme: Radio-Allergo-Sorbent-Test RAST

Beurteilung: Quantitativ

Dermographismus

Indikation: Erkrankungen mit Überempfindlichkeit von Mastzellen (bei Urticariellen Läsionen)

Durchführung: mit spitzen Gegenstand wird fest über Rückenhaut gestrichen

Beurteilung:

- Normal: roter Streifen
- urtikarieller Dermographismus liegt vor bei Rötung und Quaddelbildung der Haut die über Kratzstelle hinausgeht (Dermographismus ruber et elevatus)
- Dermographismus albus: weisse Streifen durch Vasokonstriktion als Hinweis auf atopische Grundveranlagung oder bei bereits manifestem atopischen Ekzem

Therapie Grundsätze

- Hautpflege
 - o Cremes: austrocknend
 - o Hydrolotionen: leicht fettend
 - o Lipolotionen: fettend
 - o Salben: stark fettend
 - o Desinfizierend: Fuzidin (bakteriostatisch)
- Antientzündlich/Immunologisch
 - o Topische Corticosteroide
 - o Calcineurininhibitoren
 - o Systemische Corticosteroide
 - o Azathioprin, Ciclosporin, Methotrexat
 - o Biologicals: TNF-alpha (Infliximab, Etanercept)
- Antimikrobiell
 - o Anitbiotika
 - o Antimykotika
 - o Virostatika
- Antiprurigös
 - o Antihistaminika
 - o Polidecanol (Oberflächenanästhetika)
 - o Kälte, Fingernägelschneiden, Entspannungstherapie

- Keratolytisch
 - o Salicylsäure

MERKMALE WICHTIGSTE HAUTTUMORE

Epitheliale Tumore

Gutartig

- Verruca seborrhoeica / seborrhoische Keratose: v.a. in der 2. Lebenshälfte häufig vorkommender Tumor, am gesamten Integument (ausser Akren, Hand/Fusssohle und Übergangsschleimhaut), häufig multipel, zuerst polyzyklisch begrenzte Makulae dann Vergrösserung zu speckigen, papillomatösen, warzigartigen, von porenartigen Kratern durchsetzte Plaque, Farbe variabel meist braun, „wirken wie aufgeklebt“, z.T. Juckreiz

Präkanzerösen Plattenepithelkarzinom

- Leukoplakie Mundschleimhaut: weissliche Verfärbung der Mundschleimhaut mit rauer verruköser Oberfläche, nicht abwischbar
- Aktinische Keratose: durch chronische Lichtschädigung verursachte Präkanzerose am Handrücken, Gesicht. Zunächst hautfarbene kleine Läsion mit stumpfer Oberfläche die rötliche oder weissliche Färbung aufweist. Im Weiteren Verlauf kommt es zu Vergrösserung sowohl in der Fläche als auch Dicke. DD Psoriasis
- Aktinische Cheilitis: v.a. Unterlippe, langsam progrediente, weissliche leicht schuppende Entzündung mit sekundärer Erosion oder Rhagaden
- M.Bowen: spinozelluläres Karzinoma in Situ (HPV und UV): scharf und polyzyklisch begrenzte, flächige erythrosquamöse Plaque von wenigen Millimetern bis Handtellergrösse mit samtartiger Oberfläche, ähnlich wie Psoriasisplaque.
Sonderform: Erythroplasie queyrat: M.Bowen der Schleimhaut anogenital: flächig scharf und polyzyklisch begrenzte solitäre Makulae, düsterrot von mattem Glanz und samtartiger Oberfläche

Maligne

- Basalzellkarzinom/Basaliom: aus Haarfollikelkeim entstehend und deshalb nur an Haarfollikeltragenden Körperstellen! (Nie an Schleimhaut, Leistenhaut, Lippen!). Keine Präkanzerösen bekannt! 80% oberhalb Linie vom Mundwinkel zum Ohransatz. Leiteffloreszenzen sind die Basaliomknötchen (kaum sichtbar mm grosse weisslich-perlmutterartige „glasige“ Knötchen) die meist multipel in einem erythematösen Areal mit rundlicher bis polyzyklischer Begrenzung sowie Randbetonung vorkommen. Keine wesentliche Verhornung. Häufig Ulzerationen!
 - o Noduläres Basaliom: klassisch, knotenförmig, hautfarben bis rötlich, Teleangiektasien, Randwall, z.T. pigmentiert → DD Melanom
 - o Oberflächliches Basaliom: erythrosquamöser z.T. von Kruste bedeckter Tumor, oft multipel, rot schuppig
 - o Sklerosierendes Basaliom: fingerförmig und desmoplastisch (Induktion einer Fibrose), „schrumpfende Narbe“
 - o Ulzerierte Basaliome: flache Erosionen bei allen Typen möglich, Ulzeration stets schmerzlos: Ulcus rodens = flächige Ulzeration, Ulcus terebrans = tiefe Ulzeration
- Plattenepithelkarzinom/Spinözelluläreskarzinom/Spinaliom: i.d.R. entstanden aus aktinischer Keratose / M.Bowen. Bild kann variieren: verrukös, flächig, knotig-exophytisch, tief geschwürartig zerfallend, oberflächlich exulzierend, Akren mutilierende Verläufe. Meist erythematöser Randsaum, i.d.R. hyperkeratotisch (Verhornung sichtbar!)
- Keratoakanthom: niedrig-maligner Tumor des Haarfollikelepithels, durchläuft Pseudohaarzyklus und bildet sich meist zurück. solider Knoten mit zentralem Horngefüllten Krater an UV-exponierten Arealen, rasches Wachstum innerhalb Wochen entstanden (→ entscheidend für DD Basaliom)

Adnextumoren

Maligne:

- M. Paget: mamillär oder extramamillär (genitoanal, axillär, umbilical): apokrines Adenokarzinom von Drüsengang ausgehend (Mamma, Rektum) Durchsetzung der gesamten Epidermis mit Tumorzellen. Kann schon bei In-Situ-Karzinomen auftreten (duktales Mamma-CA) und Frühsymptom sein! Klinisch wie Ekze (Erythem, Schuppung, Nässen, Papeln).

Melanozytäre Tumore → Merkmal: idR pigmentiert

Gutartig:

- Nävuszellnävus („Muttermal“): kleine, scharf und relativ regelmässig begrenzte, palpable Pigmentumore
 - o Junktionaler Nävus: hellbraun, flach
 - o Compound-Nävus: dunkler, abstehend
 - o Dermaler Nävus: meist nicht pigmentiert, fest abstehend
- Erworben oder kongenitale Nävi (cave: kongenitale Nävi höheres Entartungsrisiko als erworbene Nävi)
Varianten:
 - o Spitznävus: v.a. Kopf, symmetrisch, rund-oval hellrot bis braunrot
 - o Becker-Nävus: mehrere Zentimeter grosse Hyperpigmentierung mit Hypertrichose
 - o Naevus spilus: Kombination Café-au-lait-Fleck mit NZN
 - o Naevus Sutton: depigmentierter Hof um einen NZN (Halo-Nävus)
- Dermale melanozytäre Fehlbildungen
 - o Naevus bleu: bläulicher Naevus (keine Nävuszellen!)
 - o Mongolenfleck: graublaue unscharf begrenzte grosse homogene Makula in Gesichtsregion bei Ostasiaten
 - o Naevus ota/ito: graublaue Hypermelanose im Bereich Auge (Ota) oder Schulter (Ito)
- Lentigo seniles („Leberfleck, Altersfleck“): makuläre Hyperpigmentierungen bei älteren Menschen

Präkanzerösen

- Dysplastischer Nävuszellnävus: histologisch definiert
- kongenitaler NZN: Grösse und Anzahl entscheidend
- seltener sind andere NZN Ausgangspunkt von Melanomen!
- Nur 30% der Melanome entstehen auf Boden einer Präkanzerösen

Maligne:

- Melanoma in situ / Lentigo maligna (Melanoma in situ auf sonnengeschädigter Haut): meist in UV-exponierten Arealen, scharf und bizarr begrenzte, bis zu mehreren cm grossen variablen pigmentierten Läsionen in atropher und lichtgeschädigter Haut.
- Invasives malignes Melanom
 - o Superfiziell spreitendes malignes Melanom: braun, schwarz, rötlich, horizontales Wachstum dann Tiefenwachstum, selten komplett amelanotisch, aber teilamelanotisch möglich
 - o Nodulär malignes Melanom: braunschwarzer, amelanotischer Knoten, Erosionen, Ulzerationen, geringes Flächenwachstum
 - o Lentigo maligna Melanom: in poikilodermatischer Haut alter Menschen
 - o Akral lentiginöses malignes Melanom: lange horizontale Wachstumsphase (>20cm möglich), Melanome des Nagelbettes sind meist ALM
 - o Amelanotische Melanome: v.a. noduläres Melanom oder ALM des Nagels
- DD pigmentiertes Basaliom! (Auch andere Tumore können pigmentiert sein, Basaliom jedoch am häufigsten)

Mesenchymale Tumore

Gutartig

- Fehlbildungen Gefässe: Naevus flammeus: pinkfarbene bis hellrote Hautverfärbung mit zackigem Rand und Satellitenläsionen
- Benigne Gefässtumore: Hämangiome
- Fehlbildungen BG
 - o Keloid: ausgeprägte reaktive Bindegewebshyperplasie (v.a. Schwarzafrikaner), v.a. Dekoltte und Ohren gefährdet
 - Narbenkeloid/Traumakeloid: Narbe mit krebsscherenartigen Ausläufern
 - Spontankeloid: ohne vorausgehendes Trauma
 - o Histiozytom/Dermatofibrom (Fibroma durum): gelbbraun bis dunkelbrauner gering erhabener Tumor, v.a. Unterschenkel durch Ansammlung von Histiozyten, DD NZN
- Fettgewebe: Lipom: weicher Knoten

Metastasen

Mamma-CA, Nasennebenhöhlen, Larynx, Mundhöhle....

Sonderform: Erysipelas carcinomatosum = diffuse lymphogene Metastasierung in die Haut v.a. bei

Mamma-CA. Sieht aus wie Erysipel, die Haut ist aber derb-plattenartig

WICHTIGSTE DD EFFLORESZENZEN

PRIMÄRE EFFLORESZENZEN

Makula (Fleck) (+Erytheme/Rötungen Allgemein)

Infektiös

- Makulöse infektiöse Exantheme
 - o Masern/Morbilli: Makulopapulöses Exanthem + Enanthem (Koplik'sche Flecken im Mund)
 - o Ringelröteln / Erythema infectiosum (Parvovirus 19): Exanthem aus diffusen oder figurierten Rötungen, v.a. Gesicht („slapped cheek“, Innenseiten der Extremitäten, Stamm)
 - o Röteln/Rubella: Makulopapulöses Exanthem mit Beginn im Gesicht und rascher Ausbreitung
 - o 3-Tage-Fieber / Exanthema subitum (HHV6): Nur Kinder bis 3 Jahre: plötzlich Fieber, nach Temperaturabfall Exanthem aus blassroten Makulae am Stamm, dann Extremitäten
 - o Bei EBV (Tonsillitis, Fieber, Lymphadenopathie) Ampicillingabe: makulopapulöses Exanthem durch Ampicillin bedingt!
 - o Lues
 - Syphilis Sekundärstadium
 - Syphilis Tertiärstadium: tuberöse Syphilide im Gesicht und Kapitulum = erythematöse Flecken/Knoten die im Zentrum mit Narbe abheilen und immer grösser werden, nicht-schmerzhaft
 - o Scharlach: generalisiertes kleinmakulopapulöses Exanthem mit Petechien, typische Aussparung Mund-Kinn-Dreieck, Desquamation plantar und palmar, Erdbeerzunge, Gaumen/Rachen/Tonsillenschwellung (durch Toxine Streptokokken)
 - o Erythema anulare: bei rheumatischem Fieber auftretendes flüchtiges (h-d) gyriertes, landkartenartiges Exanthem v.a. Stamm, Achselhöhlen, Extremitäten
 - o Toxin-Schock-Syndrom: akut scarlatiniformes Exanthem, Fieber, Muskelsz, Leber/Nierenversagen, Bewusstseinsbeeinträchtigung
 - o Staphylococcal scaled skin syndrome: beginnt mit kleinfleckigem Exanthem, dann grossflächige Erytheme, schlaffe Blasen, Erosionen, Desquamation, Nikolski I positiv
- Impetigo contagiosa (Bakterielle Infektion / Pyodermie durch Staph/Streptokokken): rasch entstehende, nässende Flecken und Krusten v.a. im Gesicht
- Erysipel: scharf begrenztes Erythem, hochrot, flammenförmige zentrifugale Ausbreitung, Eintrittspforte, Allgemeinsymptome
- Phlegmone: unscharf begrenzte teigig schmerzhaft Entzündung, z.T. Blasen oder Nekrotischer Verlauf
- Lymphangitis: von Eintrittsstelle zu regionärem LK ziehende, lineare Rötung
- Oberflächliche Dermatophytose (Mykose): randbetonte sich zentrifugal ausbreitende Herde mit Rötung, leichter Infiltration und Schuppung, Juckreiz, Zentrum häufig normal
- Pityriasis versicolor (Mykose): pityriasiforme (Kleieartige) Flecken in den Seborrhoischen Arealen v.a. Stamm, z.T. Schuppung. Alba-Form: depigmentierte weissliche Herde umgeben von gebräunter Haut (Sommer). Rubra-Form: rote Herde umgeben von weisser Haut (Winter)
- Erythrasma: Pseudomykose (bakteriell): scharf begrenzte, rötliche bis bräunliche Herde in Intertrigines, kein Juckreiz, keine Streuherde, minime Schuppung
- Pediculosis pubis (Filzläuse): typische Maculae caeruleae (Taches bleues)=diskrete blaue Makel, in Gebieten mit apokrinen Drüsen (Genital, axillär, Augenwimpern, Bart), praktisch kein Juckreiz

- Lyme Borreliose: Erythema chronicum migrans (Stadium I): roter Ring der sich zentrifugal ausbreitet unter Abblassung des Zentrums ca. 10-14d nach Zeckenstich
- Larva migrans: schlangenartige Rötung (Urlaubsdermatose!)
- Zerkariendermatitis: nach Baden juckendes makulöses Erythem nach 10 h einzelstehende stark juckende Papeln

Allergisch/Autoimmun

- Makulopapulöses Arzneimittlexanthem: Auftreten nach 7-14d (bei Sensibilisierung nach 2-3d) mit Beginn am Stamm/proximale Extremitäten, Juckreiz → typischerweise bei Rezidiv an genau gleicher Stelle (fixes Arzneimittlexanthem)
Sonderform DRESS Gesichtssödem, makulopapulöses Exanthem, Erythrodermie, Exfoliative Dermatitis = Abschuppung sowie Allgemeinsymptome und Eosinophilie > 1500/l
- SJS/TEN: scharfe purpuriforme Makula z.T. kokardenartig mit Blasenbildung im Zentrum, dann grossflächige Desquamation mit nachfolgenden Erosionen, Schleimhautbeteiligung
- Dermatitis solaris (Sonnenbrand): Scharf auf lichtexponierte Hautareale begrenzte flächige Erytheme, scharf, überwärmt, z.T. mit Blasen (Verbrennung 2. Grades)
- Phototoxische Dermatitis (Lichtdermatose): scharf begrenzte flächige Erytheme, z.T. mit bizarren Formen
- Photoallergische Dermatitis (Lichtdermatose): flächiges Erythem an UV-exponierten Stellen sowie Streuung nicht-exponierte Areale, Papulovesikel, Blasen, Lichenifikation; typischer Kinnschatten und retroaurikuläre Aussparung, geht in flächige Schuppung über
- Makulopapulöses Stauungsekzem (Stadium II chronisch venöse Insuffizienz): Dermo-Epidermitis mit Nässen, Krusten, Schuppung, Papeln, typischerweise beide Beine betroffen
- Stauungspurpura (Stadium II chronisch venöse Insuffizienz): nicht palpable Purpura → sek. Purpura/Dermite jaune d'ocre (Abbau der Erythrozyten mit rot brauner Hyperpigmentierung)
- Urticaria pigmentosa: zahlreiche hyperpigmentierte Makulae/Papeln v.a. Stamm, Oberarme, Oberschenkel, Darier-Zeichen positiv
- Windeldermatitis: erythematöse, z.T. nässende und schuppig Makulae/Papeln

Kollagenosen / Vaskulitiden

- Purpurische Maculae (=nicht-palpable Purpura) bei Vaskulitis: z.T. kokardenartig
- Livedo reticularis = livide netzförmige regelmässige Hautzeichnung / Marmorierung, harmlos, reversibel bei Erwärmung (junge Frauen, betont untere Extremität)
- Livedo racemosa = livide netzförmige unregelmässige Hautzeichnung, auch am Stamm möglich, bei Vaskulitiden oder thrombosierenden Gefässverschlüssen
- Dermatomyositis (Kollagenose): ödematöses heliotropes Erythem = symmetrisch konfluierendes fliederfarbenedes Erythem v.a. Dorsalseite Hände/Finger, Arme, Schultern (jeweils über den Gelenken akzentuiert!), periungual, Nacken=Shawl-Zeichen, Hals, Dekoltee, Gesicht (v.a. Lid), Gesäss
- SLE: Schmetterlingserythem + erhöhte Lichtempfindlichkeit
- Akuter kutaner LE: limitierte Form: Schmetterlingserythem, generalisierte Form: morbilliforme Exantheme v.a. Streckseiten Arme und Hände (Gelenke ausgespart!), z.T. bullös (Lyell)
- Subakut kutaner LE: Annuläre Form/Polyzyklische Läsionen v.a. Rücken, Decoltee, Arme + extreme Photosensibilität + Fieber/Arthralgien
- Sklerodermie: Raynaudphänomen bei progressiv systemischer Sklerodermie und generalisierter Morphea (CREST)
- Sklerodermie: Morphea → lilafarbenes Erythem (Lilac-Ring) im Primärstadium

Übliche Dermatosen:

- Rosazea: Stadium erythematoteleangiectaticum: flushartiges später persistierendes Erythem des zentralen Gesichts sowie Teleangiectasien auf Nase und Wangen durch Reize ausgelöst
- Psoriasis: scharf begrenzte, intensive Rötung
 - o Psoriasis vulgaris: erythemasquamöse Plaque: primär Papeln die konfluieren=Plaque, silber-weissliche Schuppung typischerweise Streckseitenbetont v.a. Ellbogen und Knie behaarter Kopf, Bauchnabel, Analfalte, scharf begrenzt, Nagelbeteiligung, Psoriasis arthritis
 - o Psoriasis inversa: scharf begrenzte intensive Hautrötung/Plaque, nur sehr geringe Schuppung, untypische Lokalisationen (Beugefalten, perianal, Axillär, Handfläche/Fusssohle)
 - o Psoriasis guttata: Postinfektiös, kleinfleckig akut exanthemisch, nur wenig schuppig
 - o Psoriatische Erythrodermie: Rötung gesamtes Integument mit Plaques und Schuppung

Andere:

- Dekubitus: Unscharfes Erythem über Knochenprominenzen (Stadium I)
- Purpura
 - o Purpura fulminans: hämorrhagische Infarzierung(=Gangrän) der Haut bei DIC mit unscharf begrenzten Blutungen, tiefen hämorrhagischen Nekrosen
 - o Meningokokkensepsis / Friedrichsen-Waterhouse-Syndrom: initial makulöse bis urtikarielle Exantheme mit Petechien, Nekrosen, hämorrhagischen Blasen, dann Vollbild mit peripherer symmetrischer Gangrän

Tumor, Paraneoplasien

- Mycosis fungoides Stadium 1(=kutanes T-Zell-Lymphom): rot-bräunlicher Fleck an nicht-sonnenexponierten Arealen
- Kaposi Sarkom (HHV8): bei HIV Patienten meist Integument und hautnahe Mukosa, initial rote Maculae dann Wachstum zu lividen Knoten und Plaques
- Sarkoidose: bräunlich-gelbliche Makulae/Erytheme z.T. papulös, plaqueartig
- Tuberkuloide Lepra: diffus begrenzte rötliche Flecken, symmetrisch, häufig hypopigmentierte Areale, trockene Haut, Gesicht, Gesäss, Beine
- Akanthosis nigricans maligna (Paraneoplasie): braun-schwarze verruköse Hyperpigmentierung v.a. in grossen Beugen, symmetrisch, plötzliches Auftreten, starker Juckreiz, später Lichenifikation
- Erythema gyratum repens (Paraneoplasie): bandartig gyriertes urtikarielles Exanthem mit typischer randbetonter Schuppung
- Xeroderma pigmentosum: Lentiginen solares bereits im Kindesalter in UV-bestrahlten Bereichen (sowie zusätzlich Teleangiectasien, Hautatrophie, Spinaliome, Basaliome, Melanome)
- Cafe au lait Flecken = milchkaffeibraune rundliche Flecken (assoz. Mit NF1)

Papula (Knötchen)

Infektiös:

- Makulopapulöse infektiöse Exantheme:
 - o Masern/Morbilli: Makulös bis papulöses Exanthem und Enanthem (Mund: Koplik'sche Flecken)
 - o Röteln/Rubella: Makulopapulöses Exanthem mit Beginn im Gesicht und rascher Ausbreitung
 - o Bei EBV (Tonsillitis, Fieber, Lymphadenopathie) Ampicillingabe: makulopapulöses Exanthem durch Ampicillin bedingt!

- Scharlach: generalisiertes kleinmakulopapulöses Exanthem mit Petechien, typische Aussparung Mund-Kinn-Dreieck, Desquamation plantar und palmar, Erdbeerzunge, Gaumen/Rachen/Tonsillenschwellung (durch Toxine Streptokokken)
- Toxin-Schock-Syndrom: akut scarlatiniformes Exanthem, Fieber, Muskelsz, Leber/Nierenversagen, Bewusstseinsbeeinträchtigung
- Furunkel: akut entzündliche, schmerzhafte Knoten mit zentralen Einschmelzung, Abstossen des nekrotischen Pfropfes
- Pediculosis capitis (Kopfläuse): urtikarielle Papeln v.a. im Nacken und retroaurikulär mit starkem Juckreiz
- Pediculosis corporis/vestimentorum (Kleiderläuse): urtikarielle Papeln und Quaddel, Juckreiz, Hyper- und Hypopigmentierungen sind typisch
- Cimicosis (Wanze): papulo-urtikarielle Läsionen mit zentralem Punctum (Bissstelle), morgendlicher Juckreiz, häufig linear angeordnet („Wanzenstrasse“)
- Pulicosis (Flöhe): juckende erythro-urtikarielle Papeln, Purpura pulicosa Dreierkonfiguration (breakfast, lunch, dinner) an bedeckten Körperstellen
- Insektenstiche: Persistierende Reaktionen als Papeln/Pseudolymphom
- Myiasis (Fliegenlarven): Papeln mit zentraler Delle wodurch Larve atmet
- Skabies (Krätze): heftig juckendes, von Kratzartefakten dominiertes papulo-vesikulöses Exanthem, z.T. Gänge sichtbar, Prädisloktionsstellen Genital, Interdigital, volares Handgelenk, axillär, Mammae, Nabel (typisch ausgespart Gesicht, Handflächen, Fusssohlen)
- Sonderform granulomatöse Skabies: persistierende juckende Papeln (Pseudolymphom)
- Demodikose (Haarbalgmilbe): follikulär gebundene Papeln v.a. im Gesicht
- Thrombidiose (Herbstmilbe): Makula/Quaddel dann Papeln (Herbst, Erntesaison) → disseminiert papulovesikulöses Exanthem mit starkem Juckreiz
- Zerkariendermatitis: nach Baden juckendes makulöses Erythem nach 10 h einzelstehende stark juckende Papeln
- Verrucae vulgares (normale Hautwarzen HPV): hart, hautfarben oder bräunlich, verruköse Oberfläche (= rau, höckrig), v.a. Fingerstreckseiten, Handrücken, periungual, Zwillingswarzen in Umgebung („Inokulation“)
- Verrucae planae (Flachwarzen HPV): flache plateauartige Papeln, meist hautfarben, v.a. Gesicht und Handrücken
- Verrucae filiformes (gestielte Warze HPV): v.a. Gesicht (Lider, Nase) und Hals
- Verrucae palmares/plantares (endophytische Warze HPV): v.a. durch Druck endophytisch (nach innen) wachsende Warzen, kaum erhaben, „Dorn“, v.a. Fusssohle
- Mosaikwarzen (HPV Immunsupprimierte): mehrere konfluierende Warzen
- Epidermodysplasia verruciformis Lewandowski-Lutz (HPV) : disseminierte leicht erhabene Flachwarzen bei Kindern (autosomal dominante Erkrankung die Kinder empfänglich für HPV machen)
- Condyloma acuminata (HPV): zuerst kleine Papeln, später verruköse Plaques im Anogenitalbereich → Buschke-Löwenstein-Tumor = sehr grosse Condylome (Condylomata gigantea)
- Mollusca contagiosa (Pockenviren): Dellwarzen: kleine hautfarbene Papeln mit zentralem Krater (eingedellte Papeln), werden langsam grösser, meist multipel (<20), v.a. Gesicht, Stamm, Beugen
- Syphilis Sekundärstadium
- Sarkoidose: bräunlich-gelbliche Makulae/Erytheme z.T. papulös, plaqueartig
- Tuberculosis verrucosa cutis (Inokulation Tbc): warzenartige Papeln mit rotem Hof, wird mit der Zeit grösser und zusätzlich Eiteraustritt
- Hautbefall bei Miliar-Tbc: Haut mit stecknadelgrossen bläuroten Papeln, bläschenförmig
- Papulonekrotisches Tuberkulid (bei Tbc): Streckseiten Extremitäten nekrotisch zerfallende dunkelrote Papeln

- Kutane Leishmaniose: an nicht-bedeckten Körperstellen: zuerst juckende insektenstichartige Läsion → demarkierte Papeln → hyperkeratotische Plaques → Ulcus mit Randwall

Allergisch / Autoimmun

- Makulopapulöses Arzneimittlexanthem: Auftreten nach 7-14d (bei Sensibilisierung nach 2-3d) mit Beginn am Stamm/proximale Extremitäten, Juckreiz → typischerweise bei Rezidiv an genau gleicher Stelle (fixes Arzneimittlexanthem)
- DRESS: Gesichtssödem, makulopapulöses Exanthem, Erythrodermie, Exfoliative Dermatitis = Abschuppung sowie Allgemeinsymptome und Eosinophilie >1500/l
- Polymorphe Lichtdermatose: kleine juckende Papeln/Papulovesikel (seltener Plaques, Einblutungen, Blasen, Prurigo-Knoten) an UV-exponierten Stellen
- Photoallergische Dermatitis (Lichtdermatose): flächiges Erythem an UV-exponierten Stellen sowie Streuung nicht-exponierte Areale, Papulovesikel, Blasen, Lichenifikation; typischer Kinnschatten und retroaurikuläre Aussparung, geht in flächige Schuppung über
- Makulopapulöses Stauungsekzem (Stadium II chronisch venöse Insuffizienz): Dermo-Epidermitis mit Nässen, Krusten, Schuppung, Papeln, typischerweise beide Beine betroffen
- Urticaria pigmentosa: zahlreiche hyperpigmentierte Makulae/Papeln v.a. Stamm, Oberarme, Oberschenkel, Darier-Zeichen positiv
- Mastozytom: rötlich-bräunliche Plaques oder Knoten mit urtikariellem Anschwellen auf mechanischem Reiz (Darier-Zeichen), v.a. Kleinkinder <2 Jahre
- Windeldermatitis: erythematöse, z.T. nässende und schuppig Makulae/Papeln
- Atopische Dermatitis: erythematöse feine Papeln, Krusten, Kratzspuren, Lichenifikation, starker Juckreiz. Kleinkinder v.a. Gesicht/Kapillitium (Milchschorf) und Streckseiten, Kinder und Erwachsene Beugeseiten, volare Handfläche, Fossa poplitea

Andere:

- Lichen ruber planus flache z.T. konfluierende polygonale purpurfarbene Papeln mit pathognomischer Wickham-Streifung (netzartige Streifung, Schuppung), meist symmetrischer Befall Extremitäten v.a. Beugeseiten, z.T. Generalisiert, Juckreiz (5P: Polygonal, Papeln, Pruritus, Purpur, Penis). Meist Befall der Schleimhäute oral und genital, gleiche Morphe, seltener auch erosive/atrophe/bullöse Verläufe. Nagelbefall
- Prurigo simplex (papulovesikulöse HV mit Pruritus, an zugänglichen Stellen)
- Aktinische Prurigo (Lichtdermatose): prurigoartige Läsionen durch Sonnenstrahlung v.a. bei Indianern
- Granuloma annulare: hautfarbene, derbe bogen-ringförmig angeordnete dermale Papeln/Plaques, Zentrum meist eingesunken, erhabener, weisslich-glänzender Rand, Streckseitenbetont

Übliche Dermatosen

- Psoriasis
 - Psoriasis vulgaris: erythematosquamöse Plaques: primär Papeln die konfluieren=Plaques, silber-weissliche Schuppung typischerweise Streckseitenbetont v.a. Ellbogen und Knie, scharf begrenzt, Nagelbeteiligung, Psoriasis arthritis
 - Psoriasis inversa: scharf begrenzte intensive Hautrötung/Plaques, nur wenig Schuppung, untypische Lokalisationen (Beugefalten, perianal)
 - Psoriasis guttata: Postinfektiös, kleinfleckig akut exanthemisch, nur wenig schuppig
 - Psoriatische Erythrodermie: Rötung gesamtes Integument mit Plaques und Schuppung
- Akne: Mikrozysten, Komedonen, Papeln, Pusteln, Knoten, Krusten, Narben, Hyper/Hypopigmentierung, Exkoriationen, Allg. Seborrhoe

- Rosazea: Stadium papulopustulosum: Entzündliche Knötchen auf den Erythemen und Umwandlung dieser Papeln in Pusteln, KEINE Komedonen
- Periorale Dermatitis: kleinen erythematöse Papeln, seltener auch Pusteln perioral und periokular, typische Aussparung um Mundrot (freier Saum)
- Kontaktekzem: scharf begrenzte erythematöse Makulae und Papulovesikel, akut: nässend, chronisch: schuppig, Xerosis cutis, Lichenifizierung, Rhagaden, irritativ-toxisch: v.a. Hände, allergisch: z.T. Streuherde
- Atopische Dermatitis: Erythematöse Papulovesikel, nässend mit Krusten, chronisch: Xerosis cutis mit trockener Schuppung, Lichenifizierung, Pruriginoknoten

Kollagenosen/Vaskulitiden

- Purpurische Papeln(=palpable Purpura) bei Vaskulitis (z.T. Kokardenartig)
Prototyp palpable Purpura: leukozytoklastische Vaskulitis, davon am häufigsten: Purpura Schönlein – Henoch → typisch an den Füßen und am Gesäss
- Dermatomyositis (Kollagenose): Neben heliotropem Erythem z.T. auch Papeln v.a. Hand/Finger dorsal, Ellenbogen dorsal, Schulter dorsal (jeweils Gelenkbetont), Hals/Dekolté, Gesicht (Lider); Gesäss, im chronischen Stadium Lichenoid=flechtenartige Papeln→ (Gotttron-Zeichen = pathognomisch! Rötlich livide lichenoid Papeln jeweils über Fingergelenken, Ellbogen, Knie)
- Subakut kutaner LE: Papulosquamöse Form (Psoriasiform) v.a. Rücken, Decolté, Arme + extreme Photosensibilität + Fieber/Arthralgien

HIV-assoz

- Bazilläre Angiomatose (Bartonella henselae): bei HIV gefässreiche rote papulöse Läsionen
- Kutane Kryptokokkose (Pilz): bei HIV akneiforme bis molluscoide lividrote bis lividbläuliche Papeln
- Papular pruritic eruptions of AIDS = Papulöse Dermatitis: stecknadelkopfgrosse, teils follikulär gebundene, nicht konfluierende Papeln auf trockener Haut
- Eosinophile Follikulitis (Ofuji): bei HIV extrem juckende Papeln und Pustel an Gesicht, Nacken, oberer Rumpf (akneiform)

Tumore / Paraneoplasien

- Nekrolytisches Migratorisches Erythem (Paraneoplasie): zyklische erythematöse schuppige Plaques und Papulovesikel, die zentral nekrotisch werden
- Sweet-Syndrom (Paraneoplasie): subkutane ödematöse Papeln durch ausgeschwemmte leukämische Zellen

Nodus (Knoten) / Tumor

- Tumore siehe oben
- Akne: Mikrozysten, Komedonen, Papeln, Pusteln, Knoten, Krusten, Narben, Hyper/Hypopigmentierung, Exkorationen, Allg. Seborrho
- Hidradenitis suppurativa: hochrote, sehr schmerzhaft Knoten/Zysten und Abszesse, Fistelbildung, Vernarbungen, KEINE Komedonen, in den intertriginösen Arealen (Axillär, inguinal, perianal, submammär)
- Atopische Dermatitis: Erythematöse Papulovesikel, nässend mit Krusten, chronisch: Xerosis cutis mit trockener Schuppung, Lichenifizierung, Pruriginoknoten
- Lymphozytom (Stadium II Lyme Borreliose) nach 1-6 Monaten kleiner derber blauroter Knoten, meist Ohr (Ohrläppchen, Helix) oder Mamille
- Vaskulitiden: dermale oder subkutane Knoten möglich
- Prurigo nodularis

- Aktinische Prurigo (Lichtdermatose): prurigoartige Läsionen durch Sonnenstrahlung v.a. bei Indianern
- Kutanes B-Zell-Lymphom direkt (v.a. Kapilitium, Nacken, Stamm)
- Mycosis fungoides Stadium 3 (=kutanes T-Zell-Lymphom) meist mit Erosionen/Ulzerationen kombiniert
- Kutane Leishmaniose: Papeln/Knoten, hyperkeratotischer Plaque
- Kaposi Sarkom (HHV8): bei HIV Patienten meist Integument und hautnahe Mukosa, initial rote Maculae dann Wachstum zu lividen Knoten und Plaques
- Sarkoidose: Hautknoten: stecknadel bis pflaumengrosse Knoten akneiform oder verrukös v.a. Gesicht, Hals, Stamm, Extremitäten
- Sarkoidose Erythema nodosum: reaktive HV durch Pannikulitis mit subkutanen rot-bräunlichen Knoten an Streckseite Unterschenkel
- Tuberkulöser Schanker (Inokulation Tbc): schmerzloser langsam wachsender Knoten
- Skrophuloderma (Organ-Tbc): tiefer subkutaner Knoten mit Eiter (kalter Abszess), später Ulzeration mit Eiterabgang durch Dermis
- Gumma (Organ Tbc): subkutaner Knoten, ulzerierend, Fistelbildung, v.a. Arme und Beine
- Atypische Mykobakteriose: (Mykobakterium marinum → Aquarienbesitzer): bläulich-roter entzündlicher Knoten am Inokulationsort, später Ulzeration
- Lepromatöse Lepra: diffuse Knoten, Verdickung von Nerven, meist Gesichtsbereich, z.T. groteske Fazies leonia
- Hämangiom: hellroter, scharf begrenzter knotig z.T. exophytisch wachsender Tumor, manchmal auch plaqueförmig
- Neurofibrome = weiche, eindrückbare Knoten (Klingelknopf-Phänomen) (NF1)

Quaddel (Urtica):

- Urticaria: immer Juckreiz
 - Akut (<6 Wochen)
 - Infekte
 - Medikamente: allergisch (Typ1) oder pseudoallergisch
 - Nahrungsmittel: allergisch (Typ1) oder pseudoallergisch
 - Insektengift
 - Pediculosis capitis (Kopfläuse): urtikarielle Papeln v.a. im Nacken und retroaurikulär mit starkem Juckreiz
 - Pediculosis corporis/vestimentorum (Kleiderläuse): urtikarielle Papeln und Quaddel, Juckreiz, Hyper- und Hypopigmentierungen
 - Cimicosis (Wanze): papulo-urtikarielle Läsionen mit zentralem Punctum (Bissstelle), morgendlicher Juckreiz, häufig linear angeordnet („Wanzenstrasse“)
 - Insektenstiche: juckende, schmerzhafte Quaddel, seltener Culicosis bullosa (bullöse Insektenstichreaktion)
 - Chronisch: induzierbar (>6 Wochen)
 - Physikalisch
 - Urticaria factitia: durch Scherkräfte (Reiben, Kratzen)
 - Druckurticaria: an Druckstellen (Palmae Plantae) nach langen Gehen oder Handarbeiten, (>24 h!! DD Urtikariavaskulitis)
 - Kälteurticaria: Nach Kältekontakt
 - Wärmeurtikaria: durch Wärme ausgelöst, selten, (Atopiker)
 - Solare Lichturtikaria: Quaddeln an lichtexponierten Arealen Minuten nach Sonnenexposition
 - Vibrationsurtikaria

- Cholinergische Urtikaria: kleine Quaddeln nach Anstieg Körpertemperatur (Anstrengung, scharfes Essen)
 - Kontakturtikaria: allergische oder nicht-allergische Substanzen, Sonderform: orales Allergiesyndrom
 - Aquagene Urtikaria: sehr selten
- Chronisch Spontan: (>6 Wochen)
 - Infekte
 - Arzneimittel-Pseudoallergien
 - Nahrungsmittel: Allergie, Pseudoallergie
 - Autoimmun
- >24h → Urtikariavaskulitis: Allg. HV bei Vaskulitiden, jedoch fix (>24h) und sekundär purpurische Veränderungen sowie Hyperpigmentierungen, immer Biopsie (DD verzögerte Druckurtikaria)
- kutane Mastozytosen
 - Mastozytom: rötlich-bräunliche Flecken / Plaque mit urtikariellem Anschwellen auf mechanischem Reiz (=Darier-Zeichen positiv), v.a. Kleinkinder <2 Jahre
 - Urticaria pigmentosa: zahlreiche hyperpigmentierte Makulae/Papeln v.a. Stamm, Oberarme, Oberschenkel, Darier-Zeichen positiv
- Angioödem: kein Juckreiz, Spannungsschmerzen, v.a. Lippen, Zunge, Augenlider, Rachen (Gefahr Larynxödem und Erstickten)
 - Hereditäres Angioödem: quantitativer/qualitativer C1-Esteraseinhibitor Mangel
 - Erworbenes Angioödem: erworbener C1-INH oder andere Mechanismen wie Allergie, Mastozytosen

Vesicula (Bläschen)/ Bulla (Blase):

Infektiös

- Insektenstiche: juckende, schmerzhaft Quaddel, seltener Culicosis bullosa (bullöse Insektenstichreaktion)
- Thrombidiose (Herbstmilbe): Makula/Quaddel dann Papel (Herbst, Erntesaison) → disseminiert papulovesikulöses Exanthem mit starkem Juckreiz
- Gingivostomatitis herpetica (HSV-1 Primärfektion): meist Kinder, Mundbereich gruppierte Bläschen auf rotem Grund
- Ekzema herpeticum (HSV-1 Primärfektion bei Atopikern): disseminierte Herpesbläschen ganzer Körper möglich
- Vulvovaginitis, Balanoposthitis, Zervizitis, Proktitis (HSV-2 Primärfektion): gruppierte Bläschen auf rotem Grund Genitalbereich Frau/Mann
- Inokulationsherpes (HSV-1-Primärfektion): gruppierte Bläschen auf rotem Grund an irgend einer Stelle der Haut (Wunden, Kratzer..)
- Herpes labialis / genitalis, Herpes recidivans in loco (Reaktivierung HSV-1/2): gruppierte Bläschen auf rotem Grund, gleichaltrig!
- Varizellen (VZV-Primärfektion): juckendes Exanthem, auf erythematöser Haut schubweise Bläschen (nebeneinander versch. Stadien → „Heuber-Sternkarte“: Bläschen, Erosionen, Krusten, Pusteln) gesamtes Integument
- Herpes zoster (VZV-Reaktivierung): Juckendes Exanthem, Bläschen auf 1-2 Dermatome beschränkt meist unilateral
- kleinblasige Impetigo contagiosa: kleine Bläschen, nässend → Erosionen → honiggelbe Krusten
- grossblasige Impetigo contagiosa: pralle, seröse später eitrig solitäre Blase mit rotem Hof, evt. gelb-hämorrhagische Kruste
- Ulzerierende Pyodermie: beginnt ähnlich wie Impetigo contagiosa, lividrote Infiltrate, Bläschen/Pusteln → Nekrosen und Ulzerationen, v.a. Untere Extremität
- bullöse Verlaufsvarianten: bullöses Erysipel, Phlegmone

- Syphilis Sekundärstadium

Übliche Dermatosen

- Kontaktekzem: scharf begrenzte erythematöse Makulae und Papulovesikel, akut: nässend, chronisch: schuppig, Xerosis cutis, Lichenifizierung, Rhagaden, irritativ-toxisch: v.a. Hände, allergisch: z.T. Streuherde
- Atopische Dermatitis: Erythematöse Papulovesikel, nässend mit Krusten, chronisch: Xerosis cutis mit trockener Schuppung, Lichenifizierung, Pruriginoknoten

Allergisch/Autoimmun

- Dermatitis solaris (Sonnenbrand): Scharf auf lichtexponierte Hautareale begrenzte flächige Erytheme, schaft, überwärmt, z.T. mit Blasen (Verbrennung 2. Grades)
- Polymorphe Lichtdermatose: kleine juckende Papeln/Papulovesikel (seltener Plaque, Einblutungen, Blasen, Pruriginoknoten) an UV-exponierten Stellen
- Hydroa vacciniforma (solare Dermatitis): im Kindesalter auftretende Sonderform der polymorphen Lichtdermatose mit vesikulo-bullösen z.T. hämorrhagischen Läsionen, v.a. Gesicht
- Phototoxische Dermatitis (Lichtdermatose): scharf begrenzte flächige Erytheme, z.T. mit bizarren Formen, selten bullöse Verläufe
- Photoallergische Dermatitis (Lichtdermatose): flächiges Erythem an UV-exponierten Stellen sowie Streuung nicht-exponierte Areale, Papulovesikel, Blasen, Lichenifikation; typischer Kinn Schatten und retroaurikuläre Aussparung, geht in flächige Schuppung über
- bullöses Arzneimittel Exanthem
- bullöse Genodermatose (Erbkrankheit): Epidermolysis bullosa bei Neugeborenen
- Blasenbildende Autoimmunerkrankungen:
 - Pemphigus vulgaris: fragile Blasen, meist schon Erosion, v.a. Mundschleimhaut
 - bullöses Pemphigoid: Juckreiz, generalisiert v.a. Stamm und Abdomen
 - Dermatitis herpetiformis: Juckreiz, Papulovesikel herpetiform/gruppiert, v.a. Extremitäten-Streckseite und Gesäss
- Paraneoplastischer Pemphigus: schafte Blasen und Erosionen v.a. der Mundschleimhaut
- SJS/TEN (medikamentöses Lyell): schafte purpuriforme Makula z.T. kokardenartig mit Blasenbildung im Zentrum, dann grossflächige Desquamation mit nachfolgenden Erosionen, Schleimhautbeteiligung
- Staphylococcal scaled skin syndrome (staphylogenes Lyell): beginnt mit kleinfleckigem Exanthem, dann grossflächige Erytheme, schlaffe Blasen, Erosionen, Desquamation, Nikolski I positiv

Vaskulitiden, Kollagenosen:

- Purpurische Bullae bei Vaskulitiden (=palpable Purpura), z.T. hämorrhagisch
- Dermatomyositis (Kollagenose): Neben heliotropem Erythem z.T. auch Bullae v.a. Hand/Finger dorsal, Ellenbogen dorsal, Schulter dorsal (jeweils Gelenk betont), Hals/Dekolleté, Gesicht (Lider); Gesäss
- Akuter kutaner LE: limitierte Form: Schmetterlingserythem, generalisierte Form: morbilliforme Exantheme v.a. Streckseiten Arme und Hände (Gelenke ausgespart!), z.T. bullöse Verlaufsformen möglich (Lyell)

Physikalische Ursachen: Verbrennungen, Verätzungen, Kälte (Congelatio bullosa)

Andere:

- Prurigo simplex (papulovesikulöse HV mit Pruritus an zugänglichen Stellen)
- Metabolische Erkrankungen: Porphyrie
- Bullöse Mastozytose (diffus kutane Mastozytose mit bullösem Verlauf)

- Nekrolytisches Migratorisches Erythem (Paraneoplasie): zyklische erythematöse schuppende Plaques und Papulovesikel, die zentral nekrotisch werden

Pustula:

- Follikulitis: follikulär gebundene Pustel mit umgebender Rötung, eitrig Kruste, v.a. Kapillitium (Kopfhaare, Barthare), und Rumpf
- Furunkel: akut entzündliche, schmerzhaft Knoten mit zentralen Einschmelzung, Abstossen des nekrotischen Pfropfes
- Gramnegative Follikulitis: rezidivierende follikuläre Pusteln
- Psoriasis pustulosa: Psoriasis mit Pustelbildung
 - o Barber-Königsbeck: Pustulosis palmopolaris: sterile Pusteln auf Handflächen
 - o Acrodermatitis suppurativa Hallopeau: akral betonte Ausbildung entzündlicher pustulöser Veränderungen um Nagelfalz oder Zehen herum
 - o Generalisiert: ganzer Körper Erythrodermie mit Pusteln (Cave: systemische Corticosteroid-Rebound!)
- Profunde Dermatophytose (Mykose): stark entzündlich infiltrierte follikuläre und perifollikuläre Herde mit eitrig Einschmelzung der Haarfollikel, Follikulitis, Pusteln. Kerion celsi=Pustel, Abszesse, Fisteln. Zusätzlich LK-Schwellung, Fieber
- Pityrosporon-Follikulitis (Mykose): monomorphe Follikulitis in den seborrhoischen Arealen
- Candida-Mykose: gerötete Papeln und Pusteln, typisch sind Satellitenpusteln, häufig Intertriginös mit Mazerationen, Pusteln zentralkonfluerend zu nässenden Herden
- Varizellen (VZV Primärinfekt): Heubner-Sternenbild mit Bläschen, Pusteln, Erosionen, Krusten gesamtes Integument
- Purpurische Pusteln bei Vaskulitiden (=palpable Purpura)
- Syphilis Sekundärstadium
- Eosinophile Follikulitis (Ofuji): bei HIV extrem juckende Papeln und Pustel an Gesicht, Nacken, oberer Rumpf (akneiform)
- Akne neonatorum: Pusteln und Komedonen bei Neugeborenen durch mütterliche Androgene
- Akne: Mikrozysten, Komedonen, Papeln, Pusteln, Knoten, Krusten, Narben, Hyper/Hypopigmentierung, Exkorationen, Allg. Seborrho
- Rosazea: Stadium papulopustulosum: Entzündliche Knötchen auf den Erythemen und Umwandlung dieser Papeln in Pusteln, KEINE Komedonen
- Periorale Dermatitis: kleinen erythematöse Papeln, seltener auch Pusteln perioral und periokular, typische Aussparung um Mundrot (freier Saum)

SEKUNDÄRE EFFLORESZENZEN

Squama (Schuppe)

Häufig:

- Xerodermie
- Psoriasis
 - o Psoriasis vulgaris: erythemosquamöse Plaque: primär Papel die konfluieren=Plaque, silbrig-weissliche Schuppung typischerweise Streckseitenbetont v.a. Ellbogen und Knie, scharf begrenzt, Nagelbeteiligung, Psoriasis arthritis
 - o Psoriasis inversa: scharf begrenzte intensive Hautrötung/Plaque, nur wenig Schuppung, untypische Lokalisationen (Beugefalten, perianal)
 - o Psoriasis guttata: Postinfektiös, kleinfleckig akut exanthemisch, nur wenig schuppend
 - o Psoriatische Erythrodermie: Rötung gesamtes Integument mit Plaques und Schuppung
- Windeldermatitis: erythematöse, z.T. nässende und schuppend Makulae/Papeln
- Atopische Dermatitis: Erythematöse Papulovesikel, nässend mit Krusten, chronisch: Xerosis cutis mit trockener Schuppung, Lichenifizierung, Pruriginoknoten

- Seborrhoisches Ekzem: unregelmässig unscharfes Erythem mit gelblich fettiger Schuppung, z.T. Plaques in seborrhoischen Arealen (Glabella, Augenbrauen, Nasolabialfalte, Schweissrinne, Axillae, Brustlinie)

-

Infektiös

- Oberflächliche Dermatophytose (Mykose): randbetonte sich zentrifugal ausbreitende Herde mit Rötung, leichter Infiltration und Schuppung, Juckreiz, Zentrum häufig normal
- Skabies (Milben): heftig juckendes, von Kratzartefakten dominiertes papulo-vesikulo-squamokrústöses Exanthem, z.T. Gänge sichtbar, Prädilektionsstellen Genital, Interdigital, volares Handgelenk, axillär, Mammae, Nabel (typisch ausgespart Gesicht, Handflächen, Fusssohlen)
- Syphilis Sekundärstadium
- Scharlach: generalisiertes kleinmakulopapulöses Exanthem mit Petechien, typische Aussparung Mund-Kinn-Dreieck, Desquamation plantar und palmar, Erdbeerzunge, Gaumen/Rachen/Tonsillenschwellung (durch Toxine Streptokokken)

Allergisch, Autoimmun, Paraneoplasien

- Photoallergische Dermatitis (Lichtdermatose): flächiges Erythem an UV-exponierten Stellen sowie Streuung nicht-exponierte Areale, typischer Kinnschatten und retroaurikuläre Aussparung, geht in flächige Schuppung über
- Subakut kutaner LE: Papulosquamöse Form (Psoriasiform) v.a. Rücken, Decolleté, Arme + extreme Photosensibilität + Fieber/Arthralgien
- Makulopapulöses Stauungsekzem (Stadium II chronisch venöse Insuffizienz): Dermo-Epidermitis mit Nässen, Krusten, Schuppung, Papeln, typischerweise beide Beine betroffen
- Erythema gyratum repens (Paraneoplasie): bandartig gyriertes urtikarielles Exanthem mit typischer randbetonter Schuppung
- Nekrolytisches Migratorisches Erythem (Paraneoplasie): zyklische erythematöse schuppende Plaques und Papulovesikel, die zentral nekrotisch werden
- Kontaktekzem: scharf begrenzte erythematöse Makulae und Papulovesikel, akut: nässend, chronisch: schuppend, Xerosis cutis, Lichenifizierung, Rhagaden, irritativ-toxisch: v.a. Hände, allergisch: z.T. Streuherde
- Grossflächige Desquamation:
 - o DRESS: Gesichtsoedem, makulopapulöses Exanthem, Erythrodermie, Exfoliative Dermatitis = Abschuppung sowie Allgemeinsymptome und Eosinophilie>1500/l
 - o Medikamentöses Lyell-Syndrom: SJS/TEN: schafte purpuriforme Makula z.T. kokardenartig mit Blasenbildung im Zentrum, dann grossflächige Desquamation mit nachfolgenden Erosionen, Schleimhautbeteiligung
 - o Styphylogenes Lyell-Syndrom: Staphylococcal scaled skin syndrom: beginnt mit kleinfleckigem Exanthem, dann grossflächige Erytheme, schlaffe Blasen, Erosionen, Desquamation, Nikolski I positiv

Andere

- Ichthyosen: fischartiges Aussehen, Verhornungsstörung mit feiner Schuppung
 - o Autosomal-dominante Ichthyosis vulgaris: feine Schuppung, Falten ausgespart, Keratosis pilaris, Prädilektionsstellen: Unterschenkelstreckseite
 - o X-chromosomal rezessive Ichthyosis vulgaris: grobe polygonale dunklere Schuppen, grossflockig, auch Beugen können befallen sein, Gesicht+ Haarboden häufig auch betroffen
- Lichen ruber planus flache z.T. konfluierende polygonale purpurfarbene Papeln mit pathognomischer Wickham-Streifung (netzformige Streifung, Schuppung), meist symmetrischer Befall Extremitäten v.a. Beugeseiten, z.T. Generalisiert, Juckreiz (SP:

Polygonal, Papeln, Pruritus, Purpur, Penis). Meist Befall der Schleimhäute oral und genital, gleiche Morphe, seltener auch erosive/atrophe/bullöse Verläufe. Nagelbefall

Crusta (Kruste)

- Akne: Mikrozysten, Komedonen, Papeln, Pusteln, Knoten, Krusten, Narben, Hyper/Hypopigmentierung, Exkorationen, Allg. Seborrho
- Atopische Dermatitis: Erythematöse Papulovesikel, nässend mit Krusten, chronisch: Xerosis cutis mit trockener Schuppung, Lichenifizierung, Prurigoknoten
- kleinblasige Impetigo contagiosa: kleine Bläschen, nässend → Erosionen → honiggelbe Krusten
- grossblasige Impetigo contagiosa: pralle, seröse später eitrige Blase (solitär oder mehrere) mit rotem Hof, evt. gelb-hämorrhagische Kruste
- HSV-1/2 nach Platzen der Bläschen bilden sich Krusten (Gingivostomatitis herpetica, Inokulationsherpes, Ezema herpeticum, Vulvovaginitis, Balanoophtitis, Zervizitis, Proktitis, Herpes labialis, Herpes recidivans in loco, Herpes genitalis)
- VZV (Varizellen, Herpes Zoster): Nebeneinander verschiedener Stadien gesamtes Integument
- Follikulitis: follikulär gebundene Pustel mit umgebender Rötung, eitrige Kruste, v.a. Kapillitium (Kopfhaare, Barthaare), und Rumpf
- Furunkel: akut entzündliche, schmerzhaftes Knoten mit zentralen Einschmelzung, Abstossen des nekrotischen Pfropfes
- Nach purpurischen Pusteln/Bullae bei Vaskulitiden
- Kratzartefakte bei Pruritus/Prurigo
- Makulopapulöses Stauungsekzem (Stadium II chronisch venöse Insuffizienz): Dermo-Epidermitis mit Nässen, Krusten, Schuppung, Papeln, typischerweise beide Beine betroffen
- Genodermatose: nach Platzen der Blase: kongenitale Epidermolysis bullosa
- Bullöse Autoimmundermatosen: nach Platzen /Kratzen: Pemphigus, Pemphigoid, Dermatitis herpetiformis
- Syphilis Sekundärstadium

Erosio (Erosion)

- Schleimhaut
 - o Mechanische Erosion
 - o Aphten: scharf begrenzte flache fibrinbelegte Ulzerationen der Mundschleimhaut (bei komplexen Formen auch genitale Ulzerationen) mit rötlichem Saum An M. Behcet denken! → Ulzerationen genital („genitale Aphten“)
 - o HSV-1/2 nach Platzen der Bläschen bilden sich polyzyklische Erosionen (Gingivostomatitis herpetica, Inokulationsherpes, Ekzema herpeticum, Vulvovaginitis, Balanoophtitis, Zervizitis, Proktitis, Herpes labialis, Herpes recidivans in loco, Herpes genitalis)
 - o Candidose
 - o Erosiver oraler Lichen ruber planus
 - o Erythema multiforme
 - o Karenz: Vit B12, Zink, Eisen
 - o Akuter kutaner Lupus erythematoses: Mundschleimhauterosionen/ulzerationen
 - o Genodermatose: Nach Platzen/Kratzen bei kongenitale Epidermolysis bullosa
 - o Bullöse Autoimmundermatosen: typisch für Pemphigus vulgaris (selten bei bullösem Pemphigoid, praktisch nie bei Dermatitis herpetiformis)
 - o Paraneoplastischer Pemphigus: scharfe Blasen und Erosionen v.a. der Mundschleimhaut
 - o Ulcus durum bei Lues (szlos)
 - o Lippen / Zungenkarzinom
- Haut

- o Mechanische Erosion
- o kleinblasige Impetigo contagiosa: kleine Bläschen, nässend → Erosionen → honiggelbe Krusten
- o HSV-1/2 nach Platzen der Bläschen bilden sich polyzyklische Erosionen (Gingivostomatitis herpetica, Inokulationsherpes, Ekzema herpeticum, Vulvovaginitis, Balanoophtitis, Zervizitis, Proktitis, Herpes labialis, Herpes recidivans in loco, Herpes genitalis)
- o VZV (Varizellen, Herpes Zoster): Nebeneinander verschiedener Stadien gesamtes Integument
- o bullöses Arzneimittelexanthem
- o SJS/TEN: scharfe purpuriforme Makula z.T. kokardenartig mit Blasenbildung im Zentrum, dann grossflächige Desquamation mit nachfolgenden Erosionen, Schleimhautbeteiligung
- o Staphylococcal scaled skin syndrom: beginnt mit kleinleckigem Exanthem, dann grossflächige Erytheme, schlaffe Blasen, Erosionen, Desquamation, Nikolski I positiv
- o Nach purpurischen Papeln/Pusteln/Bullae bei Vaskulitiden
- o Kratzartefakte bei Pruritus (s.u.)
- o Genodermatose: nach Platzen/Kratzen bei kongenitale Epidermolysis bullosa
- o Bullöse Autoimmundermatosen: nach Platzen/Kratzen: Pemphigus vulgaris, bullöses Pemphigoid, Dermatitis herpetiformis
- o Mycosis fungoides Stadium III (Tumor, assoz. Mit Erosionen)

Exkoration (Schürfung)

- Kratzartefakt bei Pruritus/Prurigo (s.u.)
- Akne: Mikrozysten, Komedonen, Papeln, Pusteln, Knoten, Krusten, Narben, Hyper/Hypopigmentierung, Exkorationen, Allg. Seborrho

Atrophie

- Altersatrophie
- Atrophe Narbe
- Lichen sclerosus: porzellanfarbige rundliche scharf begrenzte atrophische Hautveränderung, häufig im Genitalbereich (dann Juckreiz), ansonsten kein Juckreiz, tasten: hart durch Sklerose
- Acrodermatitis chronica atrophicans (Stadium III Lyme Borreliose): teigige Schwellung mit livider Rötung unscharf begrenzt (infiltratives Stadium) und dann zunehmende Atrophie der Haut (Extremitäten), Zigarettenpapierartig dünn mit Durchschimmern der Gefässe (atrophisches Stadium)
- Dermatomyositis (Kollagenose): Poikilodermie=diffuse Atrophie + Teleangiektasien + Hyper/Hypopigmentierungen im chronischen Stadium
- Sklerodermie: Sklerose und Atrophie (Madonnenfinger, Sklerodermie-Fazies)
- Atrophie blanche (Stadium II Chronisch venöse Insuffizienz): weisse Atrophie v.a. Füsse/Unterschenkelbetont meist bds

Ulzerationen / Ulcus:

- Ulcus cruris venosum (Stadium III bei chronisch venöser Insuffizienz)
- Ulcus cruris arteriosum (pAVK)
- Ulcus cruris arterio-venosum (pAVK und CVI)
- Hämostaseologische Ursachen: Protein-C-Mangel, Protein S-Mangel, ATIII-Mangel..
- Vaskulitiden
- Pyoderma gangraenosum
- Hämatologische Ursachen: Sichelzellanämie, Sphärozytose, Thalassämie
- Myeloproliferative Ursachen: PV, Thrombozythämie
- Neuropathische Ursachen

- Infektionen
- Metabolisch: Amyloidose, Gicht
- Ulzerierende Malignome
- Chemisch/Physikalische U: Verbrennung, Erfrierung, Dekubitalulzera, nach Radiatio
- Artefakte
- Necrobiosis lipoidica: flache plattenartige rötlich-gelblich-bräunliche Läsionen / Plaques mit Atrophie und Ulzerationen zentral. (Diabetes mellitus in 50%)
- Dekubitus: scharf begrenzte schmerzfreie Ulzerationen nekrotisch-entzündlich über Knochenprominenzen
- Syphilis: Ulcus durum (Primärstadium): szloses Ulkus am Eintrittsort (meist genital oder oral)
- Syphilis Tertiärstadium: Gummen = entz. Granulome überall, schmerzhaft, narbige Spontanheilung
- Ulcus molle (Hämophilus ducrey): schaftes Ulkus (aus Papel/Pustel entstanden) meist genital, oft multiple Ulcera
- Kutane Leishmaniose: an nicht-bedeckten Körperstellen: zuerst juckende insektenstichartige Läsion → demarkierte Papel → hyperkeratotische Plaque → Ulcus mit typischem Randwall
- Nekrotisierende Faszitis: foudroyanter Verlauf innerhalb Stunden grau-blau, dann nekrotisch, entland Faszien ausbreitend
- Gramnegativer Fussinfekt: wulstartig geschwollene Zehen mit interdigitalen Ulzerationen, nässend, Krusten, beissender Geruch
- Ulzerierende Pyodermie: beginnt ähnlich wie Impetigo contagiosa, lividrote Infiltrate, Bläschen/Pusteln → Nekrosen und Ulzerationen, v.a. Untere Extremität
- Karbunkel: grössere entzündliche Infiltration der Haut, brennend, zahlreiche Einschmelzungen

Fissur (Rhagade)

- Xerodermie
- Cheilitis simplex
- Perlèche
- Kontaktekzem: scharf begrenzte erythematöse Makulae und Papulovesikel, akut: nässend, chronisch: schuppig, Xerosis cutis, Lichenifizierung, Rhagaden, irritativ-toxisch: v.a. Hände, allergisch: z.T. Streuherde
- Cheilitis angularis: Erosionen, Krusten, Rhagaden im Mundwinkel, nässend, Mazeration (ggf. weisslicher Belag bei Candida, gelbe Krusten bei Bakterien)

Narbe (Cicatrix)

- chirurgische Narbe
- Verbrennungsnarbe
- Akne: Mikrozysten, Komedonen, Papeln, Pusteln, Knoten, Krusten, Narben, Hyper/Hypopigmentierung, Exkorationen, Allg. Seborrho
- Kratzartefakte bei Pruritus (s.u.)
- Diskoider=chronischer kutaner LE: erythematöse Plaques mit Hyperkeratose, Atrophie, Narbe, Depigmentierung v.a. im Gesichtsbereich (Nase, Stirn, Wange, Ohren, Kapillitium UV-Exposition), vernarbende Herde in fast allen Fällen
- Hydroa vacciniformia (Lichtdermatose): im Kindesalter auftretende Sonderform der Polymorphen Lichtdermatose mit schweren Bullae und Narbenheilung, v.a. Gesicht
- Syphilis Tertiärstadium: tuberöse Syphilide im Gesicht und Kapillitium = erythematöse Flecken/Knoten die im Zentrum mit Narbe abheilen und immer grösser werden, nicht-schaft

Lichenifikation:

- Lichen simplex chronicus
- Chronische Ekzeme

- Kratzartefakt bei Pruritus (s.u.)
- Atopische Dermatitis: erythematöse feine Papeln, Krusten, nässend, Kratzspruen, Lichenifikation, trockene Schuppung, Pruriginoknoten, starker Juckreiz. Kleinkinder v.a. Gesicht/Kapillitium (Milchschorf) und Streckseiten, Kinder und Erwachsene Beugeseiten, volare Handfläche, Fossa poplitea
- Kontaktekzem: scharf begrenzte erythematöse Makulae und Papulovesikel, akut: nässend, chronisch: schuppig, Xerosis cutis, Lichenifizierung, Rhagaden, irritativ-toxisch: v.a. Hände, allergisch: z.T. Streuherde

ANDERE BEGRIFFE

Plaque

- Psoriasis
 - o Psoriasis vulgaris: erythematosquamöse Plaque: primär Papel die konfluieren=Plaque, silber-weissliche Schuppung typischerweise Streckseitenbetont v.a. Ellbogen und Knie, scharf begrenzt, Nagelbeteiligung, Psoriasis arthritis
 - o Psoriasis inversa: scharf begrenzte intensive Hautrötung/Plaque, nur wenig Schuppung, untypische Lokalisationen (Beugefalt, perianal)
 - o Psoriasis guttata: Postinfektiös, kleinfleckig akut exanthemisch, nur wenig schuppig
 - o Psoriatische Erythrodermie: Rötung gesamtes Integument mit Plaques und Schuppung
- Oberflächliche Dermatophytose (Mykose): randbetonte sich zentrifugal ausbreitende Herde mit Rötung, leichter Infiltration und Schuppung, Juckreiz, Zentrum häufig normal
- Infiltrierte Plaques bei Vaskulitiden
- Mycosis fungoides Stadium II (=kutanes T-Zell-Lymphom) mit Nap-claire (gesunde Inseln)
- Condyloma acuminata (HPV): zuerst einzelne kleine Papeln (Warzen) die sich zu verrukösen Plaques „vermehren“ im Anogenitalbereich → Buschke-Löwenstein-Tumor = sehr grosse Kondylome (Condyloma acuminata gigantea)
- Diskoider=chronischer kutaner LE: erythematöse Plaques mit Hyperkeratose, Atrophie, Narbe, Depigmentierung v.a. im Gesichtsbereich (Nase, Stirn, Wange, Ohren, Kapillitium UV-Exposition)
- Morphea/zirkumskripte Sklerodermie: Stadium 2 mit Fibrose und zentraler Induration des Lilac-Ringes (Sklerotischer Plaque mit elfenbeinweissem Zentrum und aktivem lilafarbenen Randsaum)
- Polymorphe Lichtdermatose: kleine juckende Papeln/Papulovesikel (seltener Plaque, Einblutungen, Blasen, Pruriginoknoten) an UV-exponierten Stellen
- Morbus Favre Racouchot: chronisch aktinischer Hautschaden als plaqueförmige Maximalvariante der aktinischen Elastose mit Plaque v.a. Jochbogenbereich im Gesicht mit Komedonen und Zysten
- Kutane Leishmaniose: Papel/Knoten, hyperkeratotischer Plaque
- Kaposi Sarkom (HHV8): bei HIV Patienten meist Integument und hautnahe Mukosa, initial rote Maculae dann Wachstum zu lividen Knoten und Plaques
- Mastozytom: rötlich-bräunliche Plaque oder Knoten mit urtikariellem Anschwellen auf mechanischem Reiz (Darier-Zeichen), v.a. Kleinkinder <2 Jahre
- Granuloma annulare: hautfarbene, derbe bogen-ringförmig angeordnete dermale Papeln/Plaque, Zentrum meist eingesunken, erhabener, weisslich-glänzender Rand, Streckseitenbetont,
- Sarkoidose: bräunlich-gelbliche Makulae/Erytheme z.T. papulös, plaqueartig
- Narbensarkoidose: Erkrankung manifestiert sich an vorher unauffälligen Narben als gelb-bräunliche Plaque
- Necrobiosis lipoidica: flache plattenartige rötlich-gelblich-bräunliche Läsionen / Plaques mit Atrophie und Ulzerationen zentral. (Diabetes mellitus in 50%)
- Lupus vulgaris: szlose rot-braune Plaque und brüchige Haut v.a. Nase, Wange, Mund, Ohrläppchen

- Orifizierter Tbc: ödematöse rote Plaque, die sek. Ulzerieren kann, scharf v.a. Zunge
- Kutane Leishmaniose: an nicht-bedeckten Körperstellen: zuerst juckende insektenstichartige Läsion → demarkierte Papel → hyperkeratotische Plaque → Ulcus mit Randwall
- Nekrolytisches Migratorisches Erythem (Paraneoplasie): zyklische erythematöse schuppende Plaques und Papulovesikel, die zentral nekrotisch werden
- Acrokeratosis paraneoplastica Bazex: Hyperkeratose Gesicht, Handrücken, Ohren, Füße (Plantae) und Nagelveränderungen
- Hämangiom: hellroter, scharf begrenzter knotig z.T. exophytisch wachsender Tumor, manchmal auch plaqueförmig
- Seborrhoisches Ekzem: unregelmässig unscharfes Erythem mit gelblich fettiger Schuppung, z.T. Plaques in seborrhoischen Arealen (Glabella, Augenbrauen, Nasolabialfalte, Schweissrinne, Axillae, Brustlinie)
- Aktinische Keratose, M. Bowen: Hyperkeratose auf rötlichbrauner Plaque auf Sonnenexponierter Haut
- Fixes Arzneimittelxanthem: nummuläre münzförmige bräunlich-rote Plaque, z.T. zentrale Blasenbildung, Rezidive immer an genau derselben Stelle und gleiches Aussehen, Auch Schleimhaut oral/genital kann befallen sein

Pruritus

- Auf primär veränderte Haut
 - o Dermatosen = Hauterkrankungen
 - Ekzeme: Atopisches Ekzem, Kontaktekzem (allergisch, irritativ)
 - Arzneimittelxantheme
 - Psoriasis
 - Polymorphe Lichtdermatose: kleine juckende Papeln/Papulovesikel (seltener Plaque, Einblutungen, Blasen, Prurigo-Knoten) an UV-exponierten Stellen
 - Urtikaria jegliche Formen
 - Epizoonosen (Skabies, Läuse, Insektenstiche)
 - Pediculosis capitis (Kopfläuse): urtikarielle Papeln v.a. im Nacken und retroaurikulär mit starkem Juckreiz
 - Pediculosis corporis/vestimentorum (Kleiderläuse): urtikarielle Papeln und Quaddel, Juckreiz, Hyper- und Hypopigmentierungen
 - Cimicosis (Wanze): papulo-urtikarielle Läsionen mit zentralem Punctum (Bissstelle), morgendlicher Juckreiz, häufig linear angeordnet („Wanzenstrasse“)
 - Pulicosis (Flöhe): juckende erythro-urtikarielle Papeln, Purpura pulicosa Dreierkonfiguration (breakfast, lunch, dinner) an bedeckten Körperstellen
 - Insektenstiche: juckende, schmerzhaft Quaddel, seltener Culicosis bullosa (bullöse Insektenstichreaktion)
 - Skabies (Milben): heftig juckendes (Juckreiz v.a. bei Bettwärme), von Kratzartefakten dominiertes papulo-vesikulo-squamokrustes Exanthem, z.T. Gänge sichtbar, Prädilektionsstellen Genital, Interdigital, volares Handgelenk, axillär, Mammæ, Nabel (typisch ausgespart Gesicht, Handflächen, Fußsohlen)
Sonderform: gepflegte Skabies: scheinbar grundloser Juckreiz keine Läsionen ersichtlich durch gute Hautpflege
 - Thrombidiose (Herbstmilbe): Makula/Quaddel dann Papeln (Herbst, Erntesaison) → disseminiert papulovesikulöses Exanthem mit starkem Juckreiz
 - Larva migrans: fadenartige Rötung mit Juckreiz (Urlaubsdermatitis)

- Zerkariendermatitis: nach Baden juckendes makulöses Erythem nach 10 h einzelstehende stark juckende Papeln
 - o

Mykosen

- Oberflächliche Dermatophytose (Mykose): randbetonte sich zentrifugal ausbreitende Herde mit Rötung, leichter Infiltration und Schuppung, Juckreiz, Zentrum häufig normal
-

- HSV 1/2: häufig sowohl bei Primär und Sekundärinfektionen als Prodromi Juckreiz
- VZV: häufig bei Primär und Sekundärinfektion juckendes Exanthem
- Autoimmune bullöse Dermatosen mit Juckreiz: Bullöses Pemphigoid, Dermatitis herpetiformis
- Dermatomyositis (Kollagenose): oft starker Juckreiz
- Pityriasis rosea
- Exanthem der Schwangerschaft
- Lichen planus
- Lichen sclerosus
- Polymorphe Lichtdermatose
- Kutane Lymphome: v.a. Mycosis fungoides alle Stadien!! und Sezary
- HIV-assoz. Erkrankungen
- Porphyrie
- Mastozytose
- Acanthosis nigricans maligna: braun-schwarze verruköse Hyperpigmentierung v.a. in grossen Beugen, symmetrisch, plötzliches Auftreten, starker Juckreiz

Chronische Kratzartefakte

- o Prurigo: Prurigo simplex acuta/subacuta, Prurigo nodularis

Auf primär normales Haut, evt. sek. Kratzartefakte

- o Nicht sichtbare Dermatosen
- o Innere Krankheiten
 - Hepatisch-biliär/Cholestatisch: Zirrhose, SS, Alkoholabusus
 - Renal: Xerosis cutis, sek. Hyperparathyreoidismus, Störungen Elektrolyt-, Vitamin A-, Porphyrinhaushalt und endogene Opioide
 - Paraneoplastisch: PV, Sezary Syndrom, M. Hodgkin, Mastozytose
 - Endokrinologisch: Hyperthyreose, Hypothyreose, Sek. Hyperparathyreoidismus, Postmenopausal (genitaler Pruritus), DM, Eisenmangel, Malabsorption/Mangelernährung
 - HIV-Assoziiert: Xerosis, Ichthyosis acquisita, Demodex, Mykosen, Seborrhoische Dermatitis, Eosinophilie Follikulitis
- o Neurologische Krankheiten: Tumore, Abszesse, MS, Polyneuropathien
- o Psychische Krankheiten
 - Larvierte Depression
 - Zwangsneurosen
 - Halluzinationen
 - Dermatozoenwahn
 - Dysästhesien
 - Body dysmorphic disorder
 - Dermatitis artefacta = Selbst herbeigeführte Dermatoze
 - Dermatillomanie = Impulskontrollstörung mit ständigem Berühren, Quetschen, Kratzen (Bsp Akne excoriée, Trichotillomanie = Drang Haare auszuziehen)
 - Prurigo

- Schwangerschaft
- Iatrogen/Arzneimittel
- Exogene Faktoren

Erythrodermie

- häufige Ursachen (95%)
 - Arzneimittellexanthem = makulopapulöses Exanthem
Sonderform DRESS: Gesichtsoödem, makulopapulöses Exanthem, Erythrodermie, Exfoliative Dermatitis = Abschuppung sowie Allgemeinsymptome und Eosinophilie > 1500/l
Sonderform SJS/TEN
 - Ekzem
 - Psoriasis vulgaris (Psoriatische Erythrodermie)
 - Sezary / Mycosis fungoides Stadium IV (=primär kutane T-Zell-Lymphome)
- Seltene Ursachen :
 - Autoimmunbullöse Dermatosen
 - Physikalische/chemische Ursachen
 - Kongenitale Ichthyosen
 - GVHD
 - Leukämien
 - Skabies
 - Pityriasis rubra pilaris
 - Lichen planus
 - Chronische aktinische Dermatitis : „feuerroter Mensch“: chronische ekzematoide Läsionen (flächige erythematöse Plaques) mit Lichenifikation und Exkoriation

SCHLEIMHAUT

Ulzerationen

- Aphthen
- Lupus erythematodes
- Pemphigus vulgaris
- Herpes labialis
- Ulcus durum (Lues I): szlos
- Lippen/Zungenkarzinom

Farbveränderungen (weiss, rot, schwarz)

- Lichen ruber planus
- Lichen sclerosus
- Lupus erythematodes
- Fixes Arzneimittellexanthem
- Soor Candidose
- Leukoplakie
- Haarleukoplakie Zunge
- Kaposi-Sarkom
- Melanom
- Fordyce'scher Zustand
- Traumatische Schleimhautzyste
- Morsicatio buccarum

Wucherungen

- HPV: Warzen
- Lippen / Zungenkarzinom

NAGELVERÄNDERUNGEN

= **Onychodystrophien (Nagelplatte, Nagelfalz, Nagelmatrix, Nagelbett)**

= Sammelbezeichnung für krankhaft veränderte Nägel

- Sezary-Syndrom
- Sklerodermie: progressiv systemische Sklerose mit Onychodystrophie/Onycholyse durch mikroangiopathische Schäden

Wichtigste Erkrankungen mit Nagelveränderungen:

- Psoriasis: Ölflecken, Onycholysen, Grübchen=Tüpfelnägel
- Lichen ruber: Onychomadesis, Onycholyse, Onychorrhexis, longitudinale Rillen, Nageldystrophie

Paronychie

= bakterielle Entzündung im Bereich des Nagelwalls mit Eiterbildung, akute Rötung, Schwellung, schmerzhaft, ggf. eitrige Sekretion

Nagelfalzveränderungen, subunguale Blutungen

- ACLE (akuter kutaner Lupus erythematodes)

Nagelfalz verdickt, schmerzt bei Versuch diesen zurückzuschieben (Keining'sches Zeichen)

- Dermatomyositis chronisches Stadium

Dermatophytenbefall der Nägel = Tinea unguium (90% der Onychomykosen!)

- krümmelige, weissliche Massen subungual, später zentripetale Verdickung und Verfärbung, Wachstumsstörungen möglich bei Befall der Matrix, Zehen>Fingernägel, meist multipel

Soorparonychie (10% der Onychomykosen): wie oben

Veränderungen der Form

- Uhrglasnägel: longitudinale und transversal verstärkte Wölbung
O₂-Verminderung kardial, pulmonal, idiopathisch
- Koilonychie (Löffelnägel): konkave, löffelförmige Krümmung
Normvariante, Eisenmangel, Plummer-Vinson-Syndrom
- Pincer-Nail: verstärkte transversale Krümmung mit Einwachsen seitlich unbekannt
- Brachyonychie: Nagelbreite > Nagellänge
Vererbt, frühzeitiger Epiphysenfugenschluss
- Anonychie: fehlender Nagel oder nur teilweise ausgebildeter Nagel
Angeboren, erworben (Lichen ruber planus)

Veränderung der Oberfläche

- Grübchen: punktförmige Substanzdefekte, einzeln oder multipel
Psoriasis (grob), Alopecia areata (kleine), Atopisches Ekzem, idiopathisch
- Beau-Reil-Querfurchen: Quer verlaufende Rillen
Schwere Krankheit, Trauma, chronische Krankheiten
- Onychorrhexis: brüchige Nägel
Lichen ruber planus
- Trachyonychie: Sandpapier Nagel: wellenartige Querrillen und Fragmentierung der Nagelplatte
Alopecia areata, Chemikalien, idiopathisch

Veränderung der Farbe

- Leukonychie: Weissverfärbung der Nagelplatte durch Schädigung Matrix
 - Quer rundlich solitär: Idiopathisch, Trauma
 - Querstreifen solitär: Psoriasis
 - Querstreifen Alle Nägel: Arsen, Thallium
 - Längsstreifen multipel: M. Darier
- Scheinbare Leukonychie: Weissverfärbung durch Veränderung des darunter liegenden Gewebes (verändert sich NICHT bei Nagelwachstum)
 - o Terry Nagel: trübe Weissverfärbung endet 1mm vor distalem Nagelende: Leberzirrhose, Herzinsuffizienz, Diabetes
 - o Halb-Halb-Nägel: Proximal trüb weiss, distal bräunlich: Urämie
 - o Muehrke Bänder: Paarweise weisse Querstreifung: sek. Hypalbuminämie bei nephrot. Syndrom
- Pseudoleukonychie: Weissverfärbung nicht durch Schädigung Matrix verursacht Onychomykose
- Gelbe Nägel: durch verlangsamtes Nagelwachstum Verkrümmung und Gelbfärbung, Cuticulae verschwinden
 - Lymphödem, Bronchiektasen, Schilddrüse, RA, Penicillin
- Splitterblutungen
 - Antiphospholipidsyndrom, subakute bakterielle Endokarditis bei rheumatischem Fieber
- Subunguales Hämatom: blau-rötliche Verfärbung im Nagelbett Trauma
- Melanonychie: Dunkle Pigmentierung: unter oder im Nagel schwarz, braun, blauschwarz, grünschwarz
 - o Dunkle Längsstreifen: Melanonychia striata bei Asiaten, Dunkelhäutigen
 - o Dunkle Flecken: NVZ, Einblutungen, Infektionen (Pseudomonas, Hefen, Schimmelpilze)
 - o Punktförmig: Psoriasis, Niereninsuffizienz
 - o Diffus: endokrine Krankheiten, perniziöse ANämie
 - o Melanomverdächtig: Verdächtig sind Pigmentierungen im proximalen Nagelfalzbereich = Hutchinson-Zeichen, neue Pigmentierung >60J, Längsstreifen >3mm breit, pos. FA Melanom, veränderte Nagelstruktur → Im Zweifel immer Biopsie
- Andere Verfärbungen:
 - o Silberblau: silberhaltige Medikamente
 - o Blaurot: Zyanose
 - o Grün: Pseudomonas
 - o Gelb: Mykosen, Schimmelpilz

Veränderung Wachstumsrichtung

- Onychogrypose: Krallennagel Trauma, verminderte Blutzirkulation

Veränderung angrenzendes Gewebe

- Unguis incarnatus: eingewachsene Nagel Rundschnitten, enge Schuhe
- Paronychie: Entzündung Nagelfalz: akut durch Strepto/Staphylokokken, Viren, Pilze, chronisch durch Candida

Veränderung Nagelbefestigung

- Onycholyse: Lösung Nagelplatte von Nagelbett Trauma, Allergie, Psoriasis, Ekzeme

- Onychomadesis: Ausfallen eines Nagels Trauma, Psoriasis, Lichen ruber

Veränderung Konsistenz

- Paronychie: Verdickung Nagelplatte Erblich oder erworben
- Onychorrhexis: brüchiges Aufsplintern des Nagels meist längs Lichen ruber
- Onychoschisis: Quer verlaufende Aufspaltung der Nagelplatte Mechanisch

HAARVERÄNDERUNGEN

Vernarbende Alopezie

- Primär Haarfollikelprozess
 - o Diskoider=chronischer kutaner LE, Lichen planus
 - o Lichen ruber planus
 - o Folliculitis decalvans
 - o Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens
 - o Tinea capitis
- Primär extrafollikuläre Prozesse
 - o Tumore, Bsp Sezary
 - o Bakterielle Infekte

Nicht-vernarbende Alopezie

- Alopecia areata: herdförmig
 - o Normale Alopecia areata (kreisrunde Alopezie)
 - o Alopecia areata totalis (alle Kopfhare)
 - o Alopecia areata universalis (gesamte Körperbehaarung inkl. Wimpern, Brauen,...)
 - o Alopecia areata liminaris (linienförmig)
 - o Alopecia areata diffusa (diffuse Areale)
- Androgenetische Alopezie: regional
- Telogeneffluvien: diffus

Übermässiger Haarwuchs

- Hypertrichose
 - o Lokalisiert: angeboren (Növoide Hypertrichose, Sakral, N. Becker), erworben
 - o Generalisiert: angeboren, erworben (Medi, Dermatomyositis, Porphyria cutanea tarda, paraneoplastisch)
- Hirsutismus

Hypertrichosis lanuginosa (Präkanzerose): vermehrtes Auftreten von Lanugohaaren